



JAWABAN KONSULTASI

MR 5.2 / II / LK / R.I / 2026

|        |              |      |             |               |                   |
|--------|--------------|------|-------------|---------------|-------------------|
| Nama   | : MUSA D, TN | JK   | : Laki-Laki | Tgl. Lahir    | : 05 Oktober 1964 |
| No. RM | : 312368     | Umur | : 61 Th     | No.Konsultasi | : KM202606220012  |

Tanggal : 6/23/26, 6:51 AM  
Kepada Yth. Teman Sejawat : dr. Muhammad Ilyas, Sp.P

Dengan Hormat,

Terima kasih atas konsultasi yang disampaikan. Berdasarkan pemeriksaan kami, atas nama pasien tersebut di atas dengan diagnosa DISFAGIA ECAUSA SUSPEK NON HEMORRHAGE STROKE 3RD ATTACK DD/ HEMORHAGGE STORKE, kami menemukan hal-hal sebagai berikut :

Terima kasih atas konsul yang diberikan dari pemeriksaan didapatkan:

S :

- Pasien dikonsul dengan keluhan sulit menelan sejak 1 hari yang lalu (21/6/2026) dirasakan tiba-tiba, setiap makan minum pasien tersedak. Nyeri kepala ada, dengan intensitas sedang dirasakan hilang timbul pada seluruh bagian kepala. Mual dan muntah menyemprot tidak ada, penurunan kesadaran tidak ada, gangguan penglihatan tidak ada. Tekanan darah saat kejadian tidak diketahui
- Keluhan disertai sulit untuk berbicara, dan lemah pada keempat ekstremitas yang dirasakan sejak 2 tahun yang lalu (tahun 2024)
- pasien dirawat oleh TS Pulmonologi dengan keluhan sesak sejak 7 hari yang lalu (16/6/2026), disertai batuk lendir, dengan diagnosa Pneumonia.
- Riwayat Demam tidak ada
- Riwayat Trauma tidak ada
- Riwayat stroke sebelumnya:
  1. pada tahun 2022 dengan gejala sisa kelmahan tubuh sebelah kiri
  2. Riwayat stroke kedua pada tahun 2024 dengan gejala sisa kelemahan tubuh sebelah kanan
- Riwayat Diabetes Melitus tidak ada
- Riwayat Hipertensi ada, tidak konsumsi obat.
- Riwayat Penyakit jantung tidak diketahui
- Riwayat Kejang tidak ada
- Riwayat Hiperlipidemia tidak diketahui
- Riwayat Merokok ada
- Riwayat Batuk lama dan konsumsi OAT 6 bulan tidak ada
- Riwayat pengobatan rutin tidak ada

O :

Tekanan Darah : 180/90 mmHg  
Nadi: 101 kali permenit reguler  
Pernapasan : 24 kali permenit  
Suhu : 36.4 derajat celcius  
GCS : E4M6V5 (kesan mengantuk)  
Saturasi oksigen : 98% dengan NK 5 lpm  
FKL : kesan normal  
RM : kaku kuduk negatif  
Nn.cranialis : pupil bulat isokor 2.5 mm OD / 2.5 mm OS, RCL pos/pos RCTL pos/pos  
Nn. cranialis lain : kesan slight parese N.VII dan XII dextra tipe sentral

Motorik :

Pergerakan : menurun pada keempat extremitas  
Kekuatan : 1/3pada extremitas superior, 1/3 pada extremitas inferior  
Tonus : normal pada keempat extremitas  
Refleks Fisiologis : BPR +2/+2, TPR +2/+2, KPR +3/+2, APR +3/+2  
Refleks Patologis: HT-/-, BB +/-  
Sensorik : kesan normal  
Sistem otonom:  
BAB normal  
BAK normal

Skor Hasanuddin 10.5  
MRS score 5  
NIHSS 10

GUSS Score 12

Hasil lab 21/6/2026  
Hb 14.0  
HCT 42  
Eritrosit 5.28  
PLT 224.000  
WBC 7.570  
LED 29  
SGPT 10  
Kreatinin 0,6  
Natroum 142  
Kalium 4.3  
Klorida 104  
GDS 149

Hasil Xray thorax 21/6/2026  
Kesan:  
- Pneumonia  
- Cardiomegaly

EKG RSAJ 22/6/26  
Sinus ritme HR 112 x/i, axis Normoaxis, PR interval 0.10; gel P normal; QRS komp 0.08, q patologis 2, 3,avf;VES+ ST segmen : elevated st changes Lead V3-V6 , Gel T normal ;

- A:
1. DISFAGIA ECAUSA SUSPEK NON HEMORRHAGE STROKE 3RD ATTACK DD/ HEMORHAGGE STORKE
  2. HEMIPARESE DUPLEX
  3. DISARTHRIA
  4. COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA
  5. HIPERTENSI ESSENSIAL
  - 6 GANGGUAN NUTRISI SEDANG

Terapi:  
Cairan sesuai DPJP Utama  
1. Citicholin 500 Mg/12 jam/iv ( bila TDS &#x3E; 110 mmHg)  
2. Mecobalamin 500 mcg/24 Jam/intravena

Plan  
- Observasi KU, TTV, GCS  
- edukasi pasang NGT  
- cek Ur/Cr, profil Lipid  
- CT Scan non Kontras

Makassar , 23 Juni 2026

Dokter Konsultan,



dr. Yudi Goysal, Sp.S